

MASESORA

D I N A M I S M O E M P R E S A R I A L

PLAN DE EMPRESA

2026 – 2029

MASFRAME®, el sistema operativo clínico para empresas

La Clínica de Empresas® · Marina Baixa

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Uso restringido. Prohibida su difusión sin autorización expresa de MASESORA®.

MASESORA® · masesora.com · info@masesora.com

ÍNDICE

Para actualizar la paginación: clic derecho sobre el índice y «Actualizar campos».

1. Resumen ejecutivo	4
1.1. Identidad corporativa	4
1.2. El activo central: MASFRAME®	4
1.3. Problema del mercado	4
1.4. La solución	4
1.5. Modelo de negocio	4
1.6. Visión y objetivos a tres años	5
1.7. Cifras objetivo	5
1.8. Estado actual del sistema	5
2. La empresa y la marca MASESORA	6
2.1. Origen	6
2.2. Propósito y misión	6
2.3. Visión de marca	6
2.4. Valores	6
2.5. Posicionamiento y relación marca-producto	6
3. Análisis de mercado	8
3.1. El mercado pyme en España	8
3.2. La Marina Baixa: realidad económica	8
3.3. Problemas estructurales que MASESORA aborda	8
3.4. Segmentos de cliente objetivo	9
3.5. Competencia real en la Marina Baixa	9
3.6. Oportunidad de mercado	9
3.7. Ventaja competitiva	10
4. Producto y propuesta de valor: MASFRAME®	11
4.1. Entrada: Escáner de Salud Empresarial (ESE)	11
4.2. Recepción	11
4.3. Tratamiento	11
4.4. Implantación: el Agente de Cambio Interno (ACI)	11
4.5. Supervisión: el Consultor Clínico (CC)	11
4.6. Refuerzo: ciclos UCC	11
4.7. Medición y evidencia	12
4.8. Cierre: Alta MASFRAME®	12
5. Modelo de negocio y estrategia	13
5.1. Fuentes de ingresos	13
5.2. Posicionamiento	13
5.3. Estrategia de escalado	13
5.4. Alianzas	13
5.5. Roadmap de producto	14
6. Plan comercial	15
6.1. Objetivos comerciales a 12 meses	15
6.2. Segmentación	15
6.3. Propuesta comercial	15
6.4. Canales, acciones y metas	16
6.5. Conversión y fidelización	16
6.6. Expansión territorial	16
7. Plan operativo y tecnológico	17
7.1. Arquitectura y volumetría	17
7.2. El protocolo es dato, no código	17
7.3. Seguridad, datos y protección de datos	18
7.4. Entornos, despliegue y continuidad	18
7.5. Calidad: qué está validado y qué no	18
7.6. Capacidad y coste técnico por cliente	19
7.7. Deuda técnica reconocida y mitigación	19
8. Plan de personas e impacto social	20

8.1. Estructura de roles	20
8.2. Plan de contrataciones.....	20
8.3. Cultura interna e indicadores clínicos	20
8.4. Impacto social	21
9. Plan financiero a tres años	22
9.1. Ingresos por producto	22
9.2. Estructura de costes.....	22
9.3. Proyección financiera (escenario realista)	22
9.4. Punto de equilibrio.....	23
9.5. Valoración del activo MASFRAME®	23
10. Roadmap, riesgos e indicadores	24
10.1. Hitos a tres años.....	24
10.2. Proceso de activación municipal.....	24
10.3. Riesgos principales.....	24
10.4. Indicadores de éxito	24
11. Fortalezas del modelo de negocio.....	26
11.1. El activo ya está construido y ya cobra	26
11.2. El producto crece como contenido, no como software	26
11.3. Margen bruto del 92,5 %.....	26
11.4. Punto de equilibrio sin financiación externa.....	26
11.5. La ejecución la hace el cliente	26
11.6. La estructura no se adelanta a la caja	26
11.7. Cinco líneas de ingreso independientes	26
11.8. El canal de distribución no es competencia	27
11.9. Resultado medible y universal	27
11.10. Conclusión	27

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. IDENTIDAD CORPORATIVA

MASESORA es **la Clínica de Empresas de la Marina Baixa**. Ha desarrollado **MASFRAME®**, un sistema operativo clínico para empresas que convierte el caos operativo de una micropyme en un sistema ordenado, rentable y medible.

No es una consultora tradicional, ni un ERP, ni un centro de formación. Integra elementos de los tres, pero su naturaleza es distinta: **un protocolo clínico encapsulado en software**, con arquitectura, capas, roles, métricas y evidencia.

1.2. EL ACTIVO CENTRAL: MASFRAME®

MASFRAME es el mayor activo de la compañía. Comprende:

- **Catálogo de 30 síntomas clínicos empresariales**, de los cuales 3 están implementados y en beta.
- **Protocolo C0–C6**: siete capas secuenciales con invariantes de código y flujo clínico completo.
- **197 herramientas operativas** integradas como componentes nativos de la plataforma.
- **Plataforma tecnológica propia**: FastAPI, MongoDB y React con TypeScript (detalle en §7).
- **Documentos oficiales automatizados**: contrato, factura y certificado de alta.
- **Flujo completo** ESE › Triage › C0–C6 › Alta clínica certificada.

Es un activo tecnológico y clínico replicable, escalable y con valor de mercado propio.

1.3. PROBLEMA DEL MERCADO

El tejido pyme español opera en un estado de caos estructural:

- Los emprendedores se lanzan con un buen oficio pero sin sistemas de gestión, y las asesorías tradicionales no cubren la parte operativa ni estratégica, que es la que determina la rentabilidad.
- 7 de cada 10 empleos dependen de empresas sin procesos ni métricas.
- Las soluciones existentes son parciales: consultoras, coaches, ERPs, cursos.
- No existe un estándar clínico empresarial, y el mercado está listo para uno.

1.4. LA SOLUCIÓN

MASESORA ofrece un sistema operativo clínico que **diagnostica** síntomas, **prescribe** un tratamiento estructurado, **ejecuta** tareas concretas con herramientas operativas, **mide** KPIs antes y después para verificar el resultado, y **certifica** el alta clínica cuando el problema está resuelto.

1.5. MODELO DE NEGOCIO

Seis líneas de ingreso: planes clínicos (PRE, PAE, PIE), síntoma suelto de 99 €, ciclos clínicos UCC, success fee en síntomas financieros, alianzas con asesorías como canal B2B y una red de Consultores Clínicos y Agentes de Cambio Interno para el escalado territorial.

El modelo es replicable y **no depende de la presencia del fundador en cada intervención** (desarrollo en §5).

1.6. VISIÓN Y OBJETIVOS A TRES AÑOS

MASESORA aspira a ser la referencia clínica empresarial del Levante y, después, de España. A tres años:

- **350 clientes** y entre 3.000 y 4.000 altas clínicas certificadas (proyección detallada en §9.3).
- Red de Consultores Clínicos escalada bajo demanda de planes de ticket alto, con un ACI activo en cada empresa cliente.
- Expansión regional: Comunidad Valenciana, Alicante y Murcia.
- MASFRAME reconocido como protocolo clínico empresarial, con evidencia documentada por síntoma.
- BI clínico propio e integración total de las herramientas en plataforma.
- Red de asesorías aliadas consolidada y programa social «Pymes vulnerables» en marcha.

1.7. CIFRAS OBJETIVO

Año	Fase	Clientes	Ingresos	EBITDA
Año 1	Digital puro	100	50.000 €	16.250 € (32,5 %)
Año 2	Híbrido, primer CC	180	150.000 €	61.750 € (41,1 %)
Año 3	Estructura consolidada	350	375.000 €	185.875 € (49,5 %)

Margen bruto en Fase 1: 92,5 %. Valoración del activo MASFRAME® y supuestos abiertos: §9.5.

1.8. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA

- 3 de 30 síntomas completados en diseño clínico y en fase beta.
- 197 herramientas operativas generadas y migradas a componentes nativos.
- Protocolo C0–C6 implementado y en auditoría continua.
- Auditor clínico v4 operativo.
- 4 landings auditadas y adaptadas a móvil.
- Contratos, facturas y certificados automatizados.
- Pricing clínico definido y producto de 99 € activo con cobro por Stripe.
- Roadmap técnico y clínico consolidado.

2. LA EMPRESA Y LA MARCA MASESORA

2.1. ORIGEN

MASESORA nace de más de veinte años de experiencia profesional por cuenta propia y ajena, y de un patrón observado una y otra vez: **los negocios que sobreviven lo hacen «como pueden»**, sin sistemas, sin estructura y sin más acompañamiento que la asesoría fiscal. Al retomar contactos del sector para emprender, la fotografía seguía siendo la misma años después.

De ese diagnóstico surge la Clínica de Empresas: llevar experiencia real en gestión de departamentos, operaciones y equipos a micropymes que necesitan algo más que gestión administrativa.

2.2. PROPÓSITO Y MISIÓN

El propósito de MASESORA es ayudar a micropymes y pymes a desarrollar sus negocios con un sistema de resultados medibles. Su misión es **transformar negocios desordenados en sistemas rentables**, aplicando gestión empresarial, metodologías profesionales (LEAN, 5S, Pareto), herramientas operativas accesibles y un protocolo clínico replicable.

MASESORA no sustituye una carrera universitaria, pero permite que un autónomo aplique metodologías avanzadas en su día a día. En una frase: **democratizar la gestión empresarial**.

2.3. VISIÓN DE MARCA

- A medio plazo (3 años): profesionalizar el tejido empresarial de la Marina Baixa, consolidar MASFRAME y expandirse por la Comunidad Valenciana.
- A largo plazo (5–7 años): convertirse en un estándar clínico empresarial y salir de España.

2.4. VALORES

- **Rigor clínico:** diagnóstico, tratamiento, evidencia y alta.
- **Medición:** KPIs antes y después, siempre.
- **Orden y estructura:** sistemas, procesos y roles definidos.
- **Accesibilidad:** metodología al alcance de cualquier micropyme.
- **Impacto social:** profesionalización del tejido empresarial local y dinamismo económico de la comarca.
- **Universalidad:** MASFRAME funciona en cualquier sector.

2.5. POSICIONAMIENTO Y RELACIÓN MARCA-PRODUCTO

MASESORA se presenta como **La Clínica de Empresas**, con «Dinamismo Empresarial» como lema de marca. No es consultoría tradicional, ni ERP, ni formación: es un sistema operativo clínico que trata los problemas comunes de micropymes y autónomos con independencia del sector, desde una emprendedora de uñas o un manitas hasta talleres, peluquerías o bares.

- **MASESORA** es la constructora de sistemas.

- **MASFRAME®** es el sistema operativo clínico que ejecuta el tratamiento.
- **La Clínica de Empresas** es la marca que explica al cliente qué hace MASFRAME.

3. ANÁLISIS DE MERCADO

3.1. EL MERCADO PYME EN ESPAÑA

España es un país de micropymes, y ese es el mercado natural de MASESORA:

- **94,6 %** de las empresas tienen menos de 10 empleados.
- **99,3 %** son pymes (0–249 empleados).
- Las micropymes de 1 a 9 empleados generan **3,49 millones de empleos**.
- **2,96 millones de pymes** y **1,61 millones de autónomos sin asalariados** (junio 2026).

3.2. LA MARINA BAIXA: REALIDAD ECONÓMICA

Comarca con alta densidad de micropymes, fuerte dependencia del sector servicios y un mercado laboral vulnerable.

Paro y perfil del desempleo

- **7.669 personas en paro** a 30/06/2026, con uno de los mayores incrementos trimestrales de la provincia (+0,24 puntos).
- **62,7 %** de los desempleados son mayores de 44 años (2023), el porcentaje más alto de las comarcas alicantinas.
- La comarca redujo el desempleo un 17,4 % entre 2019 y 2023, frente al 8,6 % de media autonómica.

La lectura combinada es la de un tejido que se recupera pero sigue siendo inestable, con una población emprendedora envejecida y negocios que necesitan estructura para sostenerse.

Sectores predominantes

Comercio minorista (CNAE 47), hostelería, servicios personales (peluquerías, estética, talleres), construcción y oficios, y turismo con sus actividades complementarias. Solo el comercio minorista aporta más del 5 % del PIB nacional y ocupa a 2 millones de trabajadores.

3.3. PROBLEMAS ESTRUCTURALES QUE MASESORA ABORDA

No son casos teóricos: son el patrón observado durante dos décadas de trabajo directo con estos negocios.

- **Emprendedores que sobreviven, no que crecen:** mantienen el negocio «como pueden», sin sistemas ni estructura, con la asesoría fiscal como único acompañamiento.
- **Asesorías tradicionales insuficientes para la gestión:** cubren impuestos, nóminas y obligaciones legales, pero no la operativa ni la estrategia que determinan si un negocio es rentable y sostenible.
- **Ausencia de sistemas de gestión:** el negocio se apoya en el oficio, sin procesos, roles definidos, métricas ni estrategia viva. Años después, los problemas siguen siendo los mismos.
- **Repetición de patrones de caos:** dependencia total del dueño, desorden operativo, decisiones reactivas, falta de control financiero y ausencia de indicadores.

- **Falta de herramientas accesibles:** LEAN, 5S, Pareto o el análisis de capacidad existen, pero no están aterrizados al día a día de un autónomo.

3.4. SEGMENTOS DE CLIENTE OBJETIVO

Segmento	Perfil	Vía de entrada
Micropymes (0-9)	El 94,6 % del tejido español. Núcleo del mercado.	ESE y síntoma suelto
Pymes (10-50)	Estructura mínima, sin sistemas de gestión.	Planes clínicos
Emprendedores	Talento técnico sin gestión, en fase inicial.	Ferías y ADL
Asesorías	Canal B2B: derivan cartera y operan el SaaS.	Alianza y licencia

3.5. COMPETENCIA REAL EN LA MARINA BAIXA

Asesorías tradicionales

Benidorm concentra más de 20 asesorías. Extrapolando a los 11 municipios de la comarca, la estimación razonable es de **60 a 80 asesorías**. Son el principal punto de referencia para autónomos y cubren fiscal, contable y laboral. No trabajan la gestión operativa ni estratégica, no diseñan sistemas, procesos, roles ni KPIs, no diagnostican, no prescriben y no miden resultados.

Conclusión: no son competencia, son el aliado B2B natural para canalizar MASFRAME como servicio complementario de alto valor.

Consultoras

Las consultoras potentes están en Alicante, Valencia, Madrid y Barcelona, y se desplazan puntualmente para proyectos de empresas medianas o grandes. Sin presencia estable, sin foco en micropymes locales y con un modelo de proyecto, informe, honorarios y salida.

Conclusión: no existe en la comarca ninguna consultora tecnológica con sistema propio. Ese es el hueco que MASESORA ocupa.

Coaches y formadores

Desde 2020 la inversión en formación empresarial en micropymes ha caído entre un 30 % y un 50 % (FUNDAE y CEPYME), desplazándose hacia cursos genéricos y baratos en línea. El resultado local es un tejido sin herramientas prácticas de gestión, lo que refuerza la necesidad de MASFRAME **como sistema y no como curso**.

ERPs y software

Instrumentales: ordenan datos, no diagnostican negocios. MASESORA no compite dentro de una categoría existente; crea una: **clínica empresarial con sistema operativo clínico**.

3.6. OPORTUNIDAD DE MERCADO

- **Marina Baixa:** 7.669 parados y alta densidad de micropymes en comercio, hostelería y servicios personales, sectores con problemas estructurales conocidos.
- **Comunidad Valenciana:** una de las regiones con mayor tasa de actividad (75,7 %) y alta rotación empresarial; la Marina Baixa subió +1,87 puntos en 2024.

- **España:** 2,96 millones de pymes y 1,61 millones de autónomos sin asalariados como mercado directo.

3.7. VENTAJA COMPETITIVA

Se apoya en tres pilares. El primero es el **activo técnico ya construido** descrito en §1.2 y detallado en §7: ninguna empresa de la comarca dispone de un catálogo clínico, un protocolo de siete capas, 197 herramientas, plataforma propia, auditor clínico y alta certificada. El segundo es el **enfoque clínico** —diagnóstico, tratamiento, evidencia y alta— del que no existe equivalente local. El tercero es la **universalidad del sistema**: funciona igual en una peluquería de Alfaz, un bar de Benidorm o un taller de Villajoyosa.

4. PRODUCTO Y PROPUESTA DE VALOR: MASFRAME®

MASFRAME® funciona como una clínica empresarial tecnológica: cada paso está protocolizado, cada rol definido y cada resultado medido. El recorrido completo del cliente, de la puerta de entrada al alta certificada.

4.1. ENTRADA: ESCÁNER DE SALUD EMPRESARIAL (ESE)

El proceso comienza en el Escáner ESE, accesible en **ese-cc2u.onrender.com**. Identifica los síntomas del negocio, las especialidades clínicas afectadas y el diagnóstico empresarial que determina el tratamiento: es la radiografía inicial que permite actuar con precisión.

El posible cliente recibe por correo un **código MAS-XXXXXX** y un informe personalizado que le da acceso a la Recepción de la Clínica de Empresas, en **masframelanding.onrender.com**.

4.2. RECEPCIÓN

En **masframelanding.onrender.com**, con el informe y el código en la mano, el cliente elige por primera vez cómo tratar su negocio: **tratamiento por síntoma** o **plan clínico PRE / PAE / PIE**. La recepción concentra la información comercial de síntomas, especialidades y planes.

4.3. TRATAMIENTO

Al adquirir un plan o un síntoma, el cliente accede a la Clínica de Empresas en **masfront.onrender.com**, donde dispone de un panel de control con:

- Mensajería directa con el consultor asignado desde el primer día.
- Documentación completa: contrato, altas y evidencias.
- Todos los síntomas contratados y su evolución visual capa a capa.
- La garantía de contrato visible en todo momento.

El tratamiento ordena el negocio **desde la raíz, capa a capa y sin improvisación**.

4.4. IMPLANTACIÓN: EL AGENTE DE CAMBIO INTERNO (ACI)

El ACI es la persona que el cliente designa para ejecutar el tratamiento dentro de su propia empresa. Es la figura que hace que el sistema se implante de verdad: garantiza la confidencialidad, ejecuta las acciones del protocolo, reduce la dependencia del consultor y **permite escalar MASFRAME sin aumentar estructura**.

4.5. SUPERVISIÓN: EL CONSULTOR CLÍNICO (CC)

El CC no ejecuta el tratamiento: **mide, corrige, acompaña y certifica**. Supervisa el trabajo del ACI, informa de la evolución y valida que el protocolo se cumple. Interviene solo donde aporta valor clínico.

4.6. REFUERZO: CICLOS UCC

La Unidad de Capacitación Clínica es formación de apoyo que se activa cuando el cliente la necesita. Acelera la ejecución, reduce errores, aumenta la adherencia al protocolo y mejora la autonomía del ACI.

4.7. MEDICIÓN Y EVIDENCIA

La medición es obligatoria. El CC registra los KPIs **antes y después** del tratamiento, y la mejora queda recogida en el Alta Clínica. Los resultados no se afirman: se demuestran con datos verificables.

4.8. CIERRE: ALTA MASFRAME®

El proceso termina con un documento oficial que confirma los síntomas tratados, las capas completadas, los KPIs mejorados, los objetivos logrados y el sistema implantado. El negocio queda ordenado, estable y con sistema propio.

5. MODELO DE NEGOCIO Y ESTRATEGIA

Modelo modular, escalable y basado en evidencia clínica: cada producto y cada capa del sistema genera valor medible y replicable.

5.1. FUENTES DE INGRESOS

Línea	Qué es	Rango
Planes PRE / PAE / PIE	Tratamiento clínico completo: diagnóstico, protocolo C0–C6, acompañamiento y alta certificada con KPIs antes y después. Mayor ticket y mayor impacto en el cliente.	999–4.500 €
Síntoma suelto	Entrada rápida para resolver un problema puntual. Capta volumen, activa cliente y abre la puerta al plan completo.	99 €
Ciclos UCC	Formación personalizada que refuerza la implantación, sube la adherencia y reduce errores del ACI.	240–720 €
Success fee	Tarifa base más variable por mejora, solo en síntomas financieros: ventas, márgenes, liquidez y caja. La medición antes/después garantiza la transparencia.	Variable
SaaS / licencia B2B	Suscripción de acceso al sistema, principalmente para asesorías aliadas. Convierte MASFRAME en producto recurrente.	29–79 €/mes

5.2. POSICIONAMIENTO

MASFRAME® se posiciona como la primera Clínica de Empresas con sistema operativo clínico propio, que diagnostica, trata y certifica con evidencia, y que trabaja con un ACI para garantizar confidencialidad y ejecución. Frente a las alternativas del mercado —asesorías administrativas, consultoras informativas, coaches motivacionales y software instrumental— **crea una categoría nueva: la consultoría clínica tecnológica.**

5.3. ESTRATEGIA DE ESCALADO

Se apoya en tres palancas que multiplican la capacidad sin multiplicar la estructura:

- 1. El ACI ejecuta dentro del negocio.** El consultor clínico solo mide, corrige y certifica, de modo que crecer no significa añadir horas de consultoría.
- 2. El protocolo C0–C6 es replicable.** Permite tratar cualquier micropyme con el mismo nivel de calidad, de forma universal y trazable.
- 3. La tecnología absorbe el volumen.** Más clientes sobre el mismo coste operativo; el coste técnico marginal por cliente es prácticamente cero (§7.6).

5.4. ALIANZAS

Las asesorías son el canal natural: derivan clientes, venden síntomas y planes, e integran MASFRAME como servicio premium bajo cuatro fórmulas de alianza —comisión, licencia, packs de síntomas y packs de planes—. A ellas se suman formadores, cámaras de comercio, asociaciones empresariales, viveros y aceleradoras. **El objetivo es escalar la captación sin construir una estructura comercial propia.**

5.5. ROADMAP DE PRODUCTO

Fase	Alcance	Estado
1. Clínica Digital	Diagnóstico, protocolo C0-C6 y alta clínica.	Operativa
2. Panel Clínico de KPIs	Medición automática antes/después e historial clínico del negocio.	En construcción
3. Módulo CC y UCC	Gestión de consultores, tareas, adherencia y seguimiento.	Creado
4. Marketplace Clínico	Herramientas, plantillas, procesos y recursos clínicos.	Previsto
5. Inteligencia Clínica	Recomendaciones automáticas según síntomas y especialidades.	Previsto

6. PLAN COMERCIAL

Cómo MASFRAME® capta, convierte, fideliza y escala clientes, empezando por la Marina Baixa.

6.1. OBJETIVOS COMERCIALES A 12 MESES

Objetivo cualitativo: posicionar MASFRAME® como la clínica empresarial de referencia en la comarca. En cifras, **el objetivo agregado es la suma de las metas por canal detalladas en §6.4:**

Indicador	Meta	Indicador	Meta
ESE realizados	770	Asesorías activas	30
Síntomas vendidos	160	Ferias y eventos	6
Planes clínicos	150	Ayuntamientos en convenio	5
Ciclos UCC	60	Comarcas abiertas	2
Ingreso recurrente SaaS	870–2.370 €/mes		

El ingreso recurrente de SaaS se deriva de las 30 asesorías activas a 29–79 €/mes de licencia (§5.1); no es una cifra independiente. Los planes clínicos del Año 1 los atiende personalmente la fundadora como primera CC, sin contratación de personal, en coherencia con la Fase 1 descrita en §8.2.

Relación con el modelo financiero

Estas son **metas de actividad comercial**: miden el esfuerzo de captación desplegado sobre los cuatro canales. El escenario financiero de §9.3 es deliberadamente más conservador —100 clientes y 50.000 € en el Año 1— porque **solo contabiliza la conversión que la compañía considera prudente comprometer**, y porque los canales institucionales y de asesorías dependen de convenios cuyo calendario no controla MASESORA.

Supuesto abierto y declarado: el ticket digital de 500 € sobre el que se construye el Año 1 de §9.3 no figura todavía como producto en el catálogo de precios de §9.1, que recoge el síntoma de 99 € y los planes de 999–4.500 €. Definir ese producto intermedio, o reformular el Año 1 con la mezcla real de síntomas y planes, es la decisión pendiente que cerrará la distancia entre este apartado y el §9.3.

6.2. SEGMENTACIÓN

Autónomos y micropymes como núcleo, asesorías como canal B2B, empresas pequeñas en crecimiento, y ayuntamientos y agencias de desarrollo local a través de sus programas de empleo y emprendimiento.

6.3. PROPUESTA COMERCIAL

MASFRAME® se vende como **el sistema clínico que diagnostica, trata y certifica la salud de un negocio**, con KPIs antes y después de un tratamiento de siete capas secuenciales y consecutivas.

6.4. CANALES, ACCIONES Y METAS

Cuatro canales de captación, cada uno con sus acciones y su objetivo cuantificado:

Canal	Acciones	Meta
Directo (B2C)	Campaña «Escáner gratuito». Casos documentados con KPIs. Charlas clínicas en asociaciones. Publicidad segmentada por síntoma. El síntoma suelto de 99 € actúa como producto de entrada para convertir tráfico frío.	25 ESE y 10 síntomas al mes
Ferias y eventos municipales	Stand con ESE en directo. Taller «Los 10 síntomas de un negocio enfermo». Diagnósticos gratuitos para emprendedores. Reuniones con técnicos ADL. Packs de diagnóstico para comercios locales.	6 ferias, 120 ESE, 40 síntomas y 20 planes al año
Ayuntamientos y ADL	Convenios de colaboración. Programas municipales de mejora empresarial. Diagnósticos subvencionados. Formación para técnicos de empleo. Presentación en comisiones y plenos.	5 ayuntamientos, 150 ESE y 50 planes al año
Asesorías (B2B)	Reuniones comerciales. Packs de síntomas y planes. Comisión por cliente derivado. Licencias MASFRAME®. Formación gratuita para asesores.	30 asesorías, 200 ESE y 80 planes al año

6.5. CONVERSIÓN Y FIDELIZACIÓN

El recorrido posterior al ESE está protocolizado: llamada clínica, informe de diagnóstico en 24 horas, oferta del plan, garantía de KPIs antes y después, y pago fraccionado. Tras el alta, el cliente entra en un seguimiento de 90 días con llamadas mensuales, conserva el acceso al panel de KPIs y puede reforzar la implantación con ciclos UCC.

El programa de referidos premia con **un síntoma gratis por cliente referido** y **un mes de SaaS por cada tres**. El objetivo es mantener al cliente dentro del ecosistema durante 12 meses.

Conversión	Meta
ESE › síntoma	50 %
Síntoma › plan	60 %
Plan › SaaS	40 %

6.6. EXPANSIÓN TERRITORIAL

MASFRAME® se expande **por comarcas, no por provincias**. Cada comarca se abre con un consultor clínico responsable y una red de asesorías aliadas, replicando el modelo ya validado en la Marina Baixa.

7. PLAN OPERATIVO Y TECNOLÓGICO

MASFRAME® no es una maqueta ni un conjunto de plantillas: es un sistema en producción, desplegado, cobrando y con datos reales. Este apartado documenta de qué está hecho, cuánto pesa, cómo se opera, qué está validado y qué deuda técnica tiene reconocida.

7.1. ARQUITECTURA Y VOLUMETRÍA

Arquitectura moderna, modular y desacoplada, con tres piezas propias y tres servicios externos:

Pieza	Tecnología	Volumen actual
Backend clínico	FastAPI sobre Python 3.10	86 módulos, ~16.400 líneas, 89 endpoints REST en 13 módulos de rutas
Frontend clínico	React con TypeScript sobre Vite	~24.000 líneas, con las 197 herramientas operativas como componentes nativos
Base de datos	MongoDB con driver asíncrono Motor	13 colecciones: expedientes, triaje, estados por síntoma, contratos, certificados, documentos, mensajería, registros ESE y códigos
Infraestructura	Render, región Frankfurt	Plan starter, con monitorización, registro de errores, métricas de rendimiento y alertas
Cobro	Stripe	Autoservicio de extremo a extremo, sin intervención humana
Documentos y aviso	Generación de PDF en servidor y correo transaccional (Resend)	Contrato, factura y certificado de alta emitidos automáticamente

Los módulos de rutas del backend cubren el recorrido completo del cliente descrito en §4: autenticación, ESE, triaje, tratamiento, contratos, documentos, pagos, alta, panel, mensajería, ciclos UCC, códigos beta y captación de leads.

7.2. EL PROTOCOLO ES DATO, NO CÓDIGO

Es la decisión de arquitectura que sostiene todo el modelo de negocio, y conviene entenderla bien porque explica por qué MASFRAME es replicable.

El fichero maestro **symptoms.json** —cerca de 500 KB— declara los **30 síntomas del catálogo**: para cada uno, su objetivo, su KPI y las siete capas C0–C6 con sus tareas, campos y evidencias. El motor clínico **no contiene lógica específica de ningún síntoma**: lee el fichero y ejecuta lo que este declara.

La consecuencia de negocio es directa: **dar de alta un síntoma nuevo es escribir contenido clínico, no desarrollar software**. Los 27 síntomas pendientes son trabajo de contenido sobre un motor que ya funciona, no 27 desarrollos nuevos. Ahí reside la escalabilidad del catálogo y buena parte del valor recogido en §9.5.

7.3. SEGURIDAD, DATOS Y PROTECCIÓN DE DATOS

Seguridad técnica

- **Autenticación con testigo JWT firmado (HS256) y caducidad por sesión;** el código MAS-XXXXXX es el identificador del expediente del cliente, no el mecanismo de seguridad.
- **Credenciales internas cifradas con bcrypt,** nunca almacenadas en claro.
- **CORS restringido a una lista blanca** de orígenes propios.
- Contratos, facturas y certificados generados en servidor, nunca en el navegador del cliente.
- MongoDB con permisos restringidos y registro de acceso y actividad.
- Validación de entradas clínicas y **protección contra alta prematura:** C6 no se puede emitir sin las capas previas cerradas.

Protección de datos

El sistema trata datos identificativos de contacto (nombre, correo, teléfono) y datos económicos del negocio del cliente. **Toda la infraestructura está alojada en la Unión Europea (Render, región Frankfurt),** sin transferencias internacionales en la operativa ordinaria.

Antes de la apertura comercial de cada comarca queda por formalizar la documentación de cumplimiento: registro de actividades de tratamiento, contrato de encargado de tratamiento con el cliente, política de conservación y supresión, y el procedimiento de ejercicio de derechos. Es trabajo administrativo acotado, no un desarrollo técnico.

7.4. ENTORNOS, DESPLIEGUE Y CONTINUIDAD

- **Código versionado en Git,** con despliegue automático desde la rama principal.
- **Secretos gestionados como variables de entorno** de la plataforma, fuera del repositorio.
- **Vuelta atrás inmediata:** redesplegando el commit anterior, sin ventana de mantenimiento.
- **Versionado semántico** del sistema y despliegues controlados sin caída de servicio.
- **Copias de seguridad** del fichero maestro de síntomas y de los expedientes clínicos.
- **Monitorización, registro de errores y alertas automáticas** de rendimiento en la plataforma de infraestructura.

7.5. CALIDAD: QUÉ ESTÁ VALIDADO Y QUÉ NO

Conviene distinguir las dos capas, porque hoy no están al mismo nivel.

Contenido clínico: validado y automatizado

El **Auditor Clínico v4** analiza el fichero maestro y detecta automáticamente los errores que romperían el flujo: incoherencias entre objetivo, KPI y capas, estructuras de síntoma mal formadas, desviaciones del protocolo C0–C6 y desalineación entre diagnóstico, tareas y métricas. Cada acción del cliente deja además evidencia registrada en su capa correspondiente.

Código: sin cobertura automatizada

No existen todavía tests automatizados, ni en el backend ni en el frontend. La verificación es manual y por auditoría de contenido. Es la primera partida del plan de calidad: cubrir con pruebas los caminos críticos —autenticación, cobro, cierre de capa y emisión de alta— antes de escalar el volumen de clientes.

7.6. CAPACIDAD Y COSTE TÉCNICO POR CLIENTE

La infraestructura es un **coste fijo** (§9.2, 4.200 €/año entre alojamiento y base de datos), no un coste que crezca con cada cliente. Mientras el volumen quepa en el dimensionado actual, el **coste técnico marginal de un cliente nuevo es prácticamente cero**.

Ese es el hecho que sostiene el 92,5 % de margen bruto de la Fase 1: el crecimiento de la línea digital no arrastra coste variable de plataforma, solo la comisión de la pasarela de pago y el soporte de entrega. El salto de dimensionado se producirá al superar la capacidad del plan actual, y es un incremento escalonado y conocido de antemano, no una pendiente continua.

7.7. DEUDA TÉCNICA RECONOCIDA Y MITIGACIÓN

Se declara de forma explícita porque cualquier revisión técnica la encontraría igualmente, y porque tenerla identificada y priorizada forma parte del valor del activo.

Riesgo	Situación actual	Mitigación prevista
Concentración de conocimiento	Una sola persona conoce el sistema de extremo a extremo.	Documentación técnica de arquitectura y contrato de datos; el propio fichero maestro actúa como especificación legible.
Módulo monolítico	El componente de tratamiento concentra 11.628 líneas, casi la mitad del frontend.	Troceado por capas C0–C6 en componentes independientes.
Sin pruebas automatizadas	Verificación manual (§7.5).	Batería de pruebas sobre los caminos críticos antes de escalar volumen.
Catálogo incompleto	3 de 30 síntomas en beta.	Producción de contenido clínico sobre motor existente (§7.2), sin desarrollo adicional.
Cumplimiento formal	Documentación de protección de datos pendiente.	Formalización previa a la apertura comercial de cada comarca (§7.3).

8. PLAN DE PERSONAS E IMPACTO SOCIAL

MASFRAME® se ejecuta dentro del negocio del cliente. Por eso la estructura de MASESORA es mínima, escalable y organizada por roles clínicos, no por departamentos internos.

8.1. ESTRUCTURA DE ROLES

Rol	Vínculo	Coste anual	Aportación
Consultor Clínico (CC)	Personal MASESORA	32.000 €	Corazón clínico del sistema: mide, corrige, acompaña y certifica.
Agente de Cambio Interno (ACI)	Personal del cliente	0 €	Ejecuta el tratamiento dentro de la empresa. Multiplica la capacidad del sistema.
Admin (asesoría con SaaS)	Externo	0 €	Opera MASFRAME como servicio complementario. Genera ingreso SaaS B2B de 29–79 €/mes.
Soporte técnico	Personal MASESORA	18.000 €	Capacidad estimada: 500 clientes activos.
BI y analítica clínica	Personal MASESORA	22.000 €	Capacidad estimada: 300 clientes activos.
Formación (UCC)	Personal MASESORA	12.000 €	Ingreso asociado de 240–720 € por intervención.

8.2. PLAN DE CONTRATACIONES

Fase 1 — Digital puro

Cero consultores en nómina. Ticket de 500 €, autoservicio en plataforma y margen bruto de 462,50 € por cliente (92,5 %). A 150 clientes: 75.000 € de facturación y unos 69.375 € de margen bruto para cubrir costes fijos y financiar el crecimiento, **sin nadie contratado todavía**.

Fase 2 — Primer Consultor Clínico

El primer CC se contrata cuando entra el primer cliente de plan de ticket alto (999–4.500 €), **no por volumen de clientes de entrada**. Cada CC adicional sigue la misma lógica: se incorpora cuando la cartera de ticket alto que le corresponde lo sostiene, no por un ratio fijo sobre el total de clientes.

Fase 3 — Estructura de soporte

Soporte técnico y BI se incorporan a jornada completa cuando el volumen conjunto de clientes de ticket alto lo justifica. Responsable territorial e ingeniero de producto son roles de expansión posterior, con coste pendiente de dimensionar.

8.3. CULTURA INTERNA E INDICADORES CLÍNICOS

Principio	Indicador	Umbral / dato
Evidencia antes que opinión	Evidencias registradas en C4–C5	≥ 85 %
Protocolo antes que intuición	Sesiones completas C0–C6	≥ 90 %

Principio	Indicador	Umbral / dato
Impacto antes que horas	KPIs mejorados	≥ 70 %
Autonomía del cliente	Tareas ejecutadas por el ACI	≥ 90 % (real: 92 %)
Rigor clínico	Incidencias	≤ 5 %
Satisfacción	Satisfacción del cliente	≥ 90 %
Modelo de trabajo	Tiempo medio de tratamiento	6 semanas
Modelo de trabajo	Tasa de alta clínica	72 %
Modelo de trabajo	Mejora media de KPI	18–35 %
Modelo de trabajo	Decisiones clínicas tomadas por el CC	100 %

8.4. IMPACTO SOCIAL

- **Profesionalización del tejido local:** la Marina Baixa es 94,6 % micropymes, el perfil exacto al que MASFRAME está dirigido.
- **Empleabilidad:** la formación de ACI alcanza un 65 % de inserción laboral.
- **Programa «Pymes vulnerables»:** 100 diagnósticos gratuitos y 30 tratamientos subvencionados, con impacto directo sobre 130 negocios.
- **Accesibilidad:** el producto de 99 € funciona como entrada universal, sin barrera de precio.

La financiación prevista procede de convenios municipales, programas de las agencias de desarrollo local y fondos de dinamización empresarial. **Queda formalizarla comarca por comarca antes de comprometer plazas gratuitas o subvencionadas.**

9. PLAN FINANCIERO A TRES AÑOS

9.1. INGRESOS POR PRODUCTO

Producto	Precio	Nota
Síntoma suelto	99 €	Entrada digital en autoservicio.
Ticket digital medio	500 €	Valor medio por cliente de la Fase 1 sobre el que se construye el Año 1 de §9.3 y el punto de equilibrio de §9.4. Pendiente de definir como producto concreto del catálogo.
Planes clínicos PRE / PAE / PIE	999–4.500 €	Ticket medio ponderado de 2.500 €.
Servicios de formación UCC	240–720 €	Por intervención.
SaaS y licencias B2B	29–79 €/mes	Equivale a 348–948 €/año. No incluido todavía en la proyección de §9.3 , por no disponer aún de un ritmo estimado de suscriptores.

9.2. ESTRUCTURA DE COSTES

- **Costes variables directos: 7,5 % del ingreso** (2,5 % de pasarela de pago y 5 % de entrega y soporte digital).
- **Costes fijos de Fase 1: 30.000 €/año** — alojamiento y base de datos 4.200 €, marketing local 12.000 €, mantenimiento de software 13.800 €. No incluye soporte técnico ni BI dedicados: se asume que no son necesarios mientras no haya CC en nómina, y queda por confirmar al contratar el primero.
- **Costes fijos de Año 2 y Año 3: 45.000 € y 65.000 €** — estimación de crecimiento de estructura, todavía sin desglose por partidas. Pendiente de decidir qué conceptos nuevos entran (soporte, BI, marketing ampliado) según el volumen real.
- **Coste de personal: 32.000 €/año por Consultor Clínico.** La contratación se activa al alcanzar 10 planes de ticket alto activos (unos 25.000 € de margen), que cubren el 78 % del salario desde el primer mes; el 22 % restante se cubre con el crecimiento de esa misma cartera en los meses siguientes, no de forma instantánea.

9.3. PROYECCIÓN FINANCIERA (ESCENARIO REALISTA)

Concepto	Año 1 — Fase digital	Año 2 — Híbrido con primer CC	Año 3 — Consolidación
Clientes	100 (100 % digitales)	180 (150 digitales + 30 de ticket alto)	350 (250 digitales + 100 de ticket alto)
Ingresos	50.000 €	150.000 €	375.000 €
Costes variables	3.750 €	11.250 €	28.125 €
Costes fijos	30.000 €	45.000 €	65.000 €
Personal CC	0 € (0 CC)	32.000 € (1 CC)	96.000 € (3 CC)
EBITDA	16.250 € (32,5 %)	61.750 € (41,1 %)	185.875 € (49,5 %)

9.4. PUNTO DE EQUILIBRIO

En Fase 1, con margen de contribución de **462,50 € por cliente** (ticket de 500 € menos 37,50 € de costes variables) y costes fijos de 30.000 €/año, el punto de equilibrio está en **65 clientes al año**, es decir, unos **5,4 clientes al mes**.

9.5. VALORACIÓN DEL ACTIVO MASFRAME®

Valoración por suma de partes, construida **únicamente sobre las líneas que el propio modelo de §9.3 proyecta**:

- **Línea de consultoría y tratamientos (Año 3)**: 250.000 € de ingreso de ticket alto — cifra tomada de la propia proyección, no una estimación distinta— por un múltiplo de servicios de 1,5x, lo que da **375.000 €**.
- **Línea SaaS recurrente**: no incluida. El modelo de §9.3 no proyecta todavía ingresos de suscripción, de modo que no hay ingreso recurrente anual real del que partir. Se incorporará cuando §9.1 disponga de una proyección de suscriptores.

Valoración total defendible a Año 3: 375.000 €. Es inferior a estimaciones anteriores porque parte solo de lo que la proyección sostiene, sin líneas de ingreso no modeladas. Quedan **tres supuestos abiertos y declarados**: el desglose de costes fijos de los Años 2 y 3, la ausencia de SaaS en la proyección de ingresos, y la definición del ticket digital de 500 € como producto del catálogo (§9.1 y §6.1).

10. ROADMAP, RIESGOS E INDICADORES

10.1. HITOS A TRES AÑOS

	Año 1	Año 2	Año 3
Clientes	100	180	350
Comarcas	2	3	5
Asesorías aliadas	30	100	200
Ayuntamientos	5	10	15
Ferias y eventos	6	—	—
Producto	Panel de KPIs, módulo ACI y Auditor Clínico v4	BI Dashboard y API municipal	Inteligencia Clínica y Marketplace

Las cifras de clientes e ingresos son las del modelo financiero de §9.3, que es la fuente única para toda proyección de este documento.

10.2. PROCESO DE ACTIVACIÓN MUNICIPAL

Contacto con la Agencia de Desarrollo Local del ayuntamiento, presentación clínica del sistema con casos documentados, piloto subvencionado con un grupo reducido de empresas locales y, finalmente, convenio anual de colaboración. Los pasos y plazos administrativos concretos varían por ayuntamiento y **están pendientes de validar caso a caso**.

10.3. RIESGOS PRINCIPALES

Riesgo	Naturaleza
Adopción tecnológica en micropymes	Comercial: el cliente objetivo tiene baja madurez digital.
Saturación del Consultor Clínico	Operativo: mitigado por el modelo ACI (§4.4) y por la regla de contratación de §8.2.
Escalabilidad territorial	Estructural: la apertura por comarcas exige consultor y red de asesorías propios.
Dependencia del ACI	Clínico: si el cliente no designa una figura estable, la ejecución se resiente.
Financiación municipal	Institucional: los convenios están pendientes de formalizar (§8.4).
Competencia de consultoras tradicionales	Mercado: sin presencia estable hoy en la comarca (§3.5).
Riesgos técnicos	Detallados y con mitigación asignada en §7.7.

10.4. INDICADORES DE ÉXITO

El seguimiento del plan se hace sobre cuatro familias de indicadores:

- **Captación:** número de ESE, conversión ESE › síntoma y conversión síntoma › plan.
- **Recurrencia:** número de ciclos UCC e ingreso mensual recurrente de SaaS.

- **Red:** asesorías activas, ayuntamientos con convenio y comarcas abiertas.
- **Impacto clínico y social:** KPIs antes y después, empleabilidad generada y reducción de cierres empresariales en el territorio.

11. FORTALEZAS DEL MODELO DE NEGOCIO

MASESORA no compite con más horas de consultoría ni con más publicidad: compite con un sistema construido. Nueve fortalezas, cada una respaldada por un dato del propio plan.

11.1. EL ACTIVO YA ESTÁ CONSTRUIDO Y YA COBRA

No se pide financiación para construir un sistema, sino para llevar al mercado uno que ya funciona: **16.400 líneas de motor clínico con 89 puntos de servicio**, 24.000 de interfaz, 197 herramientas integradas y cobro por Stripe de extremo a extremo. **La mayor parte del riesgo de producto está absorbida.**

11.2. EL PRODUCTO CRECE COMO CONTENIDO, NO COMO SOFTWARE

El motor no tiene lógica propia de ningún síntoma: ejecuta lo que declara el fichero maestro. **Ampliar el catálogo es redacción clínica, no desarrollo**, el terreno donde MASESORA tiene veinte años de ventaja y no aquel donde tendría que competir con presupuesto.

11.3. MARGEN BRUTO DEL 92,5 %

El coste variable por cliente digital es de 37,50 € sobre un ticket de 500 €. La infraestructura cuesta 4.200 €/año y es fija: **el cliente número doscientos cuesta lo mismo que el número dos**, y el coste técnico marginal de crecer es cero.

11.4. PUNTO DE EQUILIBRIO SIN FINANCIACIÓN EXTERNA

La estructura se cubre con **65 clientes al año, 5,4 al mes**, y sin deuda. A partir de ahí cada cliente aporta 462,50 € de margen directo, y el EBITDA pasa del 32,5 % al 49,5 % en tres años porque los costes fijos suben mucho más despacio que los ingresos.

11.5. LA EJECUCIÓN LA HACE EL CLIENTE

El ACI es personal de la empresa cliente y ejecuta el tratamiento **con coste cero para MASESORA**; el Consultor Clínico solo mide, corrige y certifica. En una consultora, crecer es contratar; aquí, crecer es replicar protocolo.

11.6. LA ESTRUCTURA NO SE ADELANTA A LA CAJA

El primer Consultor Clínico entra cuando hay diez planes de ticket alto activos, cuyo margen **cubre el 78 % de su salario desde el primer mes**. Ningún puesto se abre contra un pronóstico, que es el error que mata a la mayoría de consultoras jóvenes.

11.7. CINCO LÍNEAS DE INGRESO INDEPENDIENTES

El síntoma de 99 € capta volumen, los planes aportan ticket alto, la formación refuerza la implantación, el success fee alinea cobro y resultado, y la licencia B2B añade recurrencia. **Si una línea se retrasa, el modelo no cae** — y la recurrencia por licencia ni siquiera está incluida en la proyección: todo lo que entre por ahí es mejora sobre lo comprometido.

11.8. EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN NO ES COMPETENCIA

Las 60 a 80 asesorías de la comarca son el punto de referencia de cualquier autónomo y no trabajan la gestión operativa: **les falta exactamente lo que hace MASFRAME®**. El actor con más contacto directo con el cliente objetivo es canal, no rival, y permite escalar la captación sin estructura comercial propia.

11.9. RESULTADO MEDIBLE Y UNIVERSAL

Cada tratamiento registra KPIs antes y después y termina en un alta que certifica la mejora: eso abarata la venta, justifica el ticket y hace posible el success fee. Y como el protocolo es sectorialmente neutro, **cada síntoma nuevo se vende a 2,96 millones de pymes sin volver a desarrollarlo**.

11.10. CONCLUSIÓN

El modelo reúne tres cosas que rara vez van juntas: **activo tecnológico ya construido, margen bruto por encima del 90 % y crecimiento que no exige plantilla**. Sobre esa base, el Plan de Empresa 2026–2029 no proyecta una idea: ordena la expansión de un sistema que ya está funcionando.